

04 - 04- Syndrome des antiphospholipides - Pr Benjlali

Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire ce cours sur le syndrome des antiphospholipides. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Après une introduction, un chapitre sur la physiopathologie, nous aborderons le diagnostic positif, le diagnostic étiologique, l'évolution et le pronostic, un chapitre sur le traitement, avant de conclure.

Le terme anticorps antiphospholipide désigne une famille d'anticorps reconnaissant des phospholipides qui sont des constituants normaux des membranes plasmiques cellulaires. Le syndrome des antiphospholipides ou syndrome de Huggs est une maladie auto-immune définie par l'association d'événements cliniques, soit à type de thrombose et ou de manifestation obstétricale, associée à une présence durable d'anticorps antiphospholipides. Ce syndrome constitue la cause la plus fréquente de thrombophilie acquise.

Il peut être primitif ou secondaire au lupus érythémateux systémique. Ce syndrome touche surtout la femme avec un sexe ratio de 1 an pour 5 femmes et avec un âge moyen de 42 ans. Sur le plan physiopathologique, les anticorps antiphospholipides peuvent se voir dans de nombreuses situations cliniques, telles que les infections, les néoplasies, mais aussi certaines maladies auto-immunes telles que la sclérodermie et le goudreau.

Mais dans ces cas-là, ils ne s'accompagnent généralement pas de thrombophilie. Donc il faudra distinguer toujours les anticorps antiphospholipides pathogènes qui sont thrombogènes et qui rentrent dans le cadre du syndrome des antiphospholipides. Comme on l'a dit en introduction, les phospholipides sont des constituants normaux des membranes cellulaires et mitochondriales.

Les anticorps antiphospholipides reconnaissent non pas les phospholipides seuls, mais des complexes composés d'une protéine sérique appelée cofacteur et de phospholipides anioniques. Les cofacteurs comprennent la bêta₂ glycoprotéine, la prothrombine, la protéine C entre autres, la protéine S, la thrombomoduline et la myxine V. Ces protéines sont toutes impliquées dans le contrôle de la coagulation. Et la présence d'anticorps dirigés contre ces complexes cofacteurs phospholipides est susceptible d'interférer avec les mécanismes naturels anticoagulants et ainsi promouvoir la thrombose.

Ainsi, sous l'influence de facteurs génétiques et environnementaux, il y a le développement d'anticorps antiphospholipides dont le mécanisme d'action est multiple. Tout d'abord, il y a le déplacement de la balance des prostas dans le sens prothrombotique, l'inhibition de la fibrinolyse et l'activation des cellules endothéliales. Tous ces phénomènes vont contribuer à initier la thrombose et à développer les manifestations cliniques de la maladie.

Nous abordons le chapitre du diagnostic positif. Nous allons commencer par les manifestations cliniques. Les premières manifestations, ce sont les manifestations obstétricales.

Elles sont dues à l'ischémie placentaire et elles sont dominées par les avortements spontanés

récidivants survenant avant la dixième semaine de gestation et ce, sans anomalies anatomiques, chromosomiques ou hormonales connues. Il peut s'agir également d'accouchements prématurés avant la 34e semaine et qui sont liés soit à une éclampsie, une pré-éclampsie ou à une insuffisance placentaire. Il y a aussi les risques fœtaux, notamment le retard de croissance, l'hématome rétro-placentaire et l'éclampsie.

Les femmes atteintes de syndromes de antiphospholipides encourt un risque thrombotique majeur en fin de grossesse et au cours du postpartum, mais aussi un risque d'ischémie cérébrale. Et lors des procédures de stimulation de l'ovulation et en plus du risque thrombotique, le risque de pousser le pic est majoré. Après les manifestations obstétricales, il y a les manifestations non obstétricales et nous allons commencer par les thromboses qui ont la particularité de survenir sur une paroi vasculaire saine, indemne d'inflammation préalable.

Tous les vaisseaux peuvent être touchés. Les thromboses veineuses restent les plus fréquentes et surviennent dans des sites parfois inhabituels, tels que la veine cave inférieure, les veines rénales ou mésentériques. Il ne faut pas négliger de rechercher les anticorps antiphospholipides en cas de thrombose chez le sujet jeune, surtout sans facteur déclenchant.

À côté des thromboses veineuses, il y a les thromboses artérielles qui touchent surtout le système nerveux central et peuvent être à l'origine d'accidents ischémiques. L'atteinte cardiaque est représentée par l'atteinte valvulaire qui est la plus fréquente et qui comprend des anomalies similaires à celles observées au cours du lupus érythémateux systémique. Il peut s'agir d'un épaississement valvulaire, de lésions ondulaires, de végétation, dans le cadre d'une endocardite de Libman-Sachs, d'une fuite ou d'une sténose.

L'atteinte valvulaire peut parfois être sévère, nécessitant la chirurgie, et peut se compliquer par des embolies systémiques ou par une surinfection bactérienne. Deuxième atteinte cardiaque, c'est l'atteinte coronaire qui peut survenir par deux mécanismes, la thrombose et la périostose accélérées. Il faut savoir qu'un titre d'anticorps antiphospholipide élevé est un facteur de risque indépendant de survenus d'infarctus de myocarde et de décès d'origine cardiaque.

On peut également observer des thromboses massives intracardiaques qui parfois posent un problème de diagnostic différentiel avec un myxome ou une volumineuse végétation. Des cardiomyopathies dilatées peuvent également être observées. Après l'atteinte cardiaque, il y a l'atteinte neurologique dont la manifestation la plus fréquente est l'accident vasculaire cérébral ischémique transitoire ou constitué.

Il y a un grand risque de récurrence de l'AVC ischémique en l'absence de traitement, et la répétition des AVC ischémiques peut être responsable à long terme d'un état démentiel ou de troubles cognitifs variés. L'association d'un accident vasculaire cérébral ischémique et de l'IVDO avec la présence d'anticorps antiphospholipides détermine le syndrome de Snendon. L'enjeu IRM cérébral va montrer des images d'infarctus cérébraux et des hypersignaux de la substance blanche périventriculaire.

À côté des AVC ischémiques, les thrombophlébites cérébrales sont fréquentes, mais on peut observer également d'autres atteintes telles que la comitialité, la choré, les myélites transverses. L'atteinte respiratoire est dominée essentiellement par l'embolie pulmonaire qui peut parfois être grave et qui peut se compliquer d'hypertension artérielle pulmonaire post-embolique. L'atteinte rénale résulte surtout de thrombies formées soit in situ, soit à partir d'embols rénaux à point de départ cardiaque ou de gros vaisseaux.

Ces thrombies seront responsables d'infarctus ou de zones d'ischémie et de nécrose rénale avec une stimulation massive du système rénine angiotensine aldostérone à l'origine d'une hypertension artérielle secondaire, parfois sévère. La forme la plus grave d'atteinte rénale est représentée par la microangiopathie thrombotique qui associe une HTA maligne, une hémolyse mécanique et une insuffisance rénale aiguë. A côté de ces manifestations, on peut noter parfois l'existence de thromboses des artères ou des veines rénales.

L'atteinte cutanée est d'origine ischémique et elle est différente des lésions du lupus. Elle est dominée essentiellement par le livédo qui est un irritant violacé formant des mailles plus ou moins marquées et régulières sur la peau comme on le voit sur la photo. Le livédo quand il est associé à un AVC ischémique avec des antiphospholipides positifs définit le syndrome de Sneddon.

A côté du livédo, on peut observer également des ulcérations cutanées postflébitiques, un purpuronécrotique, une nécrose digitale mais aussi des flébitis superficielles ou des hémorragies sous un guéal en flammèche. L'atteinte hématologique est représentée par la thrombopénie qui peut survenir par consommation lors d'une thrombose ou par destruction par l'isothore anticorps ce qui entraîne un grand risque hémorragique. L'aggravation brutale d'une thrombopénie doit faire craindre le syndrome catastrophique des antiphospholipides.

A côté de l'atteinte hématologique, il y a l'atteinte endocrinienne qui est due à une insuffisance surénale aiguë par un infarctus hémorragique des glandes surénales. Et enfin, l'atteinte hépatique et digestive est représentée essentiellement par la thrombose d'éventus hépatiques définissant le syndrome de Butcary, un infarctus hépatique ou splénique, une thrombose porte, mais aussi, on peut craindre la survenue d'une ischémie intestinale par des microtrombies disséminées. Après les manifestations cliniques, il y a les examens complémentaires et nous allons commencer par les examens de présomption et le diagnostic de syndrome des antiphospholipides est évoqué devant une fausse sérologie syphilitique positive, à savoir une VDRL positive et un TPHA négatif.

Le dépistage des anticorps antiphospholipides va se faire par le temps de céphaline activée qui est spontanément allongé par rapport au témoin. Les examens de certitude reposent sur la mise en évidence des anticorps antiphospholipides, à savoir les anticorps anticardiolipines, les antibêtas de glycoprotéines et l'anticoagulant circulant lupique. La recherche des autres anticorps antiphospholipides n'est pas de pratique courante car elle n'a pas d'intérêt.

Après les manifestations cliniques et les examens complémentaires, il y a les critères

diagnostiques qui peuvent nous aider à poser le diagnostic du syndrome des antiphospholipides. Ces critères reposent tout d'abord sur des critères cliniques puis des critères biologiques. Les critères cliniques sont la présence de thromboses veineuses et ou artérielles, des complications obstétricales, c'est-à-dire une ou plusieurs pertes fatales survenant après la dixième semaine de gestation sans qu'il existe d'anomalie morphologique du fœtus, une ou plusieurs naissances prématurées d'un nouveau-né morphologiquement normal survenant avant la trente-quatrième semaine liée à une éclampsie, une prééclampsie ou une insuffisance placentaire, trois ou plus de fausses couches précoces survenant avant la dixième semaine de gestation sans qu'il y ait une anomalie anatomique, hormonale ou chromosomique connue.

À côté des critères cliniques, il y a les critères biologiques qui reposent sur la détection des anticorps antiphospholipides à deux reprises à au moins douze semaines d'intervalle. Le diagnostic est évoqué s'il existe l'association d'un signe clinique et d'un signe biologique à condition que les critères biologiques aient été vérifiés à douze semaines d'intervalle et qu'il n'y ait pas plus de cinq ans entre les signes cliniques et les signes biologiques. Après le diagnostic positif, il y a le diagnostic étiologique et l'enquête étiologique va répondre à la question « Quand demander une recherche des anticorps antiphospholipides ? » Cette recherche va se faire dans les situations suivantes.

Tout d'abord en cas d'antécédent de thrombose artérielle ou veineuse, des thromboses récidivantes, devant un premier épisode de thrombose veineuse de siège inhabituel, devant une première manifestation artérielle systémique chez une personne jeune de moins de 45 ans telle qu'un accident vasculaire cérébral ischémique, un infarctus du myocarde ou n'importe quel infarctus viscéral, devant des manifestations artérielles systémiques répétées sans contexte d'athérome, devant une mort fatale ou une récurrence d'avortement spontané précoce, devant une thrombopénie inexpliquée et enfin devant des symptômes divers tels qu'un livédo ou une éclampsie atypique. Les étiologies sont représentées par le syndrome des antiphospholipides primitifs et le syndrome des antiphospholipides secondaires associés au lupus, d'ailleurs les patients lupiques en principe bénéficient d'une recherche systématique des anticorps antiphospholipides. L'évolution sans traitement est émaillée par un grand risque de récurrence de thrombose et certaines localisations sont graves, notamment la thrombose cérébrale et la thrombose cardiaque, mais aussi l'embolie pulmonaire massive.

La complication majeure du syndrome des antiphospholipides est le syndrome catastrophique des antiphospholipides qui est dû à la thrombose d'au moins 3 organes. Il est volontiers favorisé par une infection, un geste chirurgical et ou un arrêt transitoire ou une modification de l'anticoagulation. Le syndrome catastrophique des antiphospholipides réalise un tableau de défaillance multiviscérale avec une atteinte rénale sévère à type d'HTMI ligne ou d'insuffisance rénale, une CIVD, des atteintes pulmonaires, neurologiques, centrales et autres.

Ce syndrome est grave car il y a un risque de mortalité de 50%. Nous arrivons au chapitre traitement. Alors le traitement du syndrome des antiphospholipides a pour but de traiter les

thromboses, de prévenir les récurrences et les complications obstétricales, de gérer la grossesse et enfin d'éviter les complications hémorragiques des traitements.

Le traitement du syndrome des antiphospholipides fait appel à l'anticoagulation qui va se faire surtout par l'héparine de bas poids moléculaire qui a actuellement supplanté les héparines non fractionnées, bien sûr après avoir réalisé un bilan minimal fait d'un hémogramme et d'une fonction rénale afin de rechercher une insuffisance rénale contraindiquant l'usage des HBPM, bien sûr il faudra surveiller ce traitement par un hémogramme bihebdomadaire afin de pouvoir dépister une thrombopénie induite par l'héparine. A côté des héparines il y a les antivitamines K qui vont prendre le relais de l'héparine pour traiter la thrombose, bien sûr la surveillance se fera par l'INR et bien sûr il faudra surveiller le patient à cause du risque hémorragique sous ce traitement. A côté de l'héparine et des antivitamines K, le traitement fait appel également à l'aspirine à doses antiagrégantes plaquettaires entre 70 et 160 mg par jour.

Le traitement du syndrome des antiphospholipides n'est pas codifié, tout d'abord il faudra prendre en charge les facteurs de risque vasculaire global chez le patient, notamment l'arrêt du tabac et des oestroprogestatifs, le traitement d'une dyslipidémie, d'un diabète ou d'une HTA, le traitement préventif des patients lupiques présentant des anticorps antiphospholipides positifs fera appel à l'antiagrégant plaquettaire au long cours. Le traitement curatif d'une thrombose veineuse fera appel à l'héparine relayée par les antivitamines K au long cours avec un INR cible entre 2 et 3, alors que le traitement curatif d'une thrombose artérielle ou d'une récurrence de thrombose veineuse visera un INR entre 3 et 4. La corticothérapie n'est pas utilisée au cours du syndrome des antiphospholipides, sauf en cas de syndrome catastrophique des antiphospholipides et il faut savoir que les anticoagulants orodirects ne doivent pas être utilisés au cours du syndrome des antiphospholipides. En conclusion, je dirais que le syndrome des antiphospholipides est une cause fréquente de thrombophilie acquise.

Il associe des manifestations thrombotiques et obstétricales avec la présence durable des antiphospholipides. Certaines complications peuvent parfois être graves et engager le pronostic vital et fonctionnel et le risque thrombotique est accru si le patient a les 3 anticorps positifs. Et enfin, le traitement repose exclusivement sur l'anticoagulation au long cours et je vous remercie.